

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

MONONUCLEOSIS

INFECCIOSAS

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

Introducción

Es una enfermedad producida por el Virus Epstein Barr, afecta principalmente en la primera infancia, adolescencia o adultos jóvenes.

Existen otros agentes que causan Síndrome Mononucleósido

Clínica y exploración.

TRIADA: fiebre + amigdalitis + poliadenopatías (cervicales anteriores y posteriores, inguinales y axilares). En la amigdalitis se aprecia exudado pultáceo extenso, similar a la faringitis estreptocócica. Se puede observar petequias en la confluencia del paladar duro con el blando. Los síntomas remiten en aproximadamente en 2-4 semanas.

- Fiebre: intensidad variable
- Angina: exudado blanquecino grisáceo que se desprende (pseudomembranosa). Se acompaña de petequias en paladar blando.
- Adenopatías +++. Típicos triángulos posteriores cervicales y axilar e inguinal.
- Hepatoesplenomegalia, ictericia. Astenia

Diagnóstico

- Hemograma: linfomonocitosis. Linfocitos atípicos. Transaminasas +++
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT (transaminasa glutámico-oxalacética), GPT (glutamato-piruvato transaminasa), Gamma-glutamyl-transferasa (GGT o Gama GT), Lactato deshidrogenasa (LDH), Amilasa, bilirruina, PCR.
- Tes de Paul-Bunnell: positivo
- Serología de virus de Epstein-Barr (VEB): positivo

Exantema con amoxicilina

Tratamiento

Reposo, analgesia, antitérmicos e hidratación

Evitar traumatismos abdominales (riesgo de ruptura bazo)

Corticoides: si hemolisis, lesiones neurológicas o hepáticas

20 % sobreinfección bacteriana. Uso de clindamicina 300 mg/8 h durante 7 días oral.

Nota

- Seriación de transaminasas de forma ambulatoria posteriormente.

Bibliografía

- Luzuriaga K, Sullivan JL. Infectious mononucleosis. N Engl J Med 2010; 362:1993.
- Odumade OA, Hogquist KA, Balfour HH Jr. Progress and problems in understanding and

managing primary Epstein-Barr virus infections. Clin Microbiol Rev 2011; 24:193.